Psychiatrische Universitätsklinik Zürich

Remission, Alltag und persönliche Recovery

Besserung ist möglich. Symptomatische Remission, Alltag und Teilhabe sowie persönliche Recovery beschreiben unterschiedliche Aspekte und müssen sich nicht gleichzeitig verändern.

DREI BLICKWINKEL – UND EIN BEGRIFF ZUR EINORDNUNG

1

Symptomatische Remission

In Verlaufsstudien bedeutet symptomatische Remission, dass die Diagnosekriterien während eines festgelegten Zeitraums nicht mehr erfüllt sind. Die genaue Definition und die verlangte Dauer unterscheiden sich zwischen Studien. Remission bedeutet nicht automatisch, dass alle Beschwerden verschwunden sind oder keine Unterstützung mehr nötig ist.

2

Alltag und Teilhabe

Beziehungen, Arbeit oder Ausbildung, Wohnen und Alltag sind eigene Lebensbereiche. Sie können sich anders und in einem anderen Tempo verändern als Symptome. Erneute Beschwerden oder Belastungen machen bereits erreichte Veränderungen nicht ungeschehen.

3

Persönliche Recovery

Persönliche Recovery beschreibt einen individuellen Weg zu einem selbstbestimmten und als sinnvoll erlebten Leben. Dazu können Hoffnung, Verbundenheit, Identität, Teilhabe und eigene Handlungsmöglichkeiten gehören. Welche Ziele bedeutsam sind, bestimmt die betroffene Person selbst.

Zum Begriff «Heilung»

«Heilung» wird unterschiedlich verstanden. Studien und Leitlinien sprechen meist nicht von «Heilung», sondern genauer von Remission, Alltag und Teilhabe, Lebensqualität oder persönlicher Recovery. Eine Einteilung in «geheilt» oder «für immer krank» wird individuellen Verläufen nicht gerecht.

VERÄNDERUNG HAT MEHRERE SEITEN

Beschwerden, Alltag und Teilhabe, Lebensqualität und persönliche Recovery können sich unterschiedlich entwickeln. Kein einzelner Begriff beschreibt den ganzen Genesungsweg oder bewertet den Wert eines Menschen.

MÖGLICHE NÄCHSTE SCHRITTE

- Vermeiden Sie Vorgaben von aussen dazu, wie schnell oder wie weit Veränderung gehen soll.
- Fragen Sie – wenn die Person darüber sprechen möchte –, welche Veränderungen für sie selbst bedeutsam sind, statt Fortschritt von aussen festzulegen.
- Nehmen Sie erneute Belastungen ernst, ohne sie als persönliches Scheitern zu deuten.
- Achten Sie zugleich auf Ihre eigenen Grenzen und Ihren Unterstützungsbedarf.

Eigene didaktische Darstellung der Fachstelle Angehörigenarbeit. Fachlicher Bezug: APA Practice Guideline for the Treatment of Patients With Borderline Personality Disorder (2024); NICE CG78; Zanarini et al. (2012, 2024); AWMF-S3 Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen (2025), Kap. 7.2.

Dieses Blatt ersetzt keine persönliche Beratung oder Behandlung.

Für Angehörige – Fachstelle Angehörigenarbeit, PUK Zürich – Ch. Egger | Entwurf – fachlich-redaktionelle Freigabe ausstehend | Stand: 05.10.2026.